



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
(PKRS)**

TAHUN 2026

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

PROGRAM KERJA TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) RS PRIMA HUSADA MALANG TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum / Latar Belakang

Dalam perkembangan pelayanan Rumah Sakit tidak terlepas dari Pembangunan ekonomi Masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitative (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi Kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Untuk mengoptimalkan upaya promosi Kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif) maka dibentuklah tim/unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS). Dalam penyelenggaraan PKRS, Kementerian Kesehatan telah mengatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Dalam Permenkes ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan Masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan Kesehatan menuju pencapaian derajat Kesehatan yang optimal.

Sehubungan dengan telah dikembangkannya Pendekatan Rumah Sakit Proaktif sejak 1997 dimana salah satu esensinya adalah Rumah Sakit Proaktif harus dapat berfungsi sebagai Rumah Sakit Promotor Kesehatan (Health Promotif Hospital) yang juga melaksanakan kegiatan promotif maupun preventif bagi Kesehatan pasien, staf rumah sakit dan Masyarakat di wilayah cakupannya serta pengembangan organisasi rumah sakit menjadi organisasi yang sehat. Gerakan menjadi Rumah Sakit Promotor Kesehatan akan menghasilkan reorientasi pelayanan rumah sakit Dimana klien rumah sakit adalah pasien dan orang sehat.

Reformasi pembiayaan melalui sistem jaminan Kesehatan kepada Masyarakat dan jaminan keuangan bagi rumah sakit dalam meningkatkan keterjangkauan pelayanan. Lebih lanjut, peningkatan mutu pelayanan Kesehatan merupakan salah satu cara RS Prima Husada Malang Kabupaten Malang untuk siap bersaing dengan rumah sakit sekitarnya. Dinamika perkembangan pelayanan kesehatan seperti yang tersebut di atas seiring dengan makin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit yang berkualitas. Kuatnya arus kompetisi di dunia perumahsakit mendorong RS Prima Husada Malang untuk berkomitmen dalam mengembangkan pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

Dalam memberikan pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) kepada pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas utama rumah sakit tanpa membedakan segmen. Oleh karena itu kemandirian pasien adalah hal penting yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit dengan melakukan Pendidikan pasien dan keluarga, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat sekitar RS Prima Husada Malang secara keseluruhan. Kinerja PKRS untuk tahun 2026 tertuang dalam program kerja PKRS dibawah ini.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
9. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHM/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan promosi dan edukasi kesehatan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan pasien, keluarga pasien, pengunjung, serta seluruh sumber daya manusia rumah sakit dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Program kerja PKRS di tahun ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), pencegahan penyakit, serta pengendalian faktor risiko kesehatan, sejalan dengan kebijakan rumah sakit di bidang kesehatan, serta standar akreditasi rumah sakit. Peran RS Prima Husada Malang sebagai institusi pelayanan kesehatan yang berkontribusi aktif dalam upaya promotif dan preventif, baik di lingkungan internal rumah sakit maupun kepada masyarakat sekitar.

2. Tujuan Umum

Terciptanya Masyarakat rumah sakit yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien/klien rumah sakit serta pemeliharaan lingkungan rumah sakit dan dimanfaatkannya semua pelayanan yang disediakan rumah sakit dengan baik oleh Masyarakat.

3. Tujuan Khusus

- a. Tersedia dan Tersampainya program kegiatan pemberian KIE kepada pasien dan keluarga baik individu atau kelompok, serta tersedia semua materi KIE untuk layanan dalam bentuk *digital*.
- b. Tersedia dan tersampainya seluruh informasi dan edukasi kepada seluruh Masyarakat rumah sakit sesuai kebutuhan Masyarakat rumah sakit melalui media seperti, Leaflet, Poster, Postingan Digital, Video Edukasi dan metode yang sesuai
- c. Melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya 5 program nasional, yaitu :
 - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2) Penurunan angka kesakitan TBC
 - 3) Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS
 - 4) Penurunan prevalensi Stunting dan Wasting
 - 5) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit
- d. Meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga untuk mengambil Keputusan dalam pelayanan Kesehatan yang dilakukan terhadap dirinya.

-
- e. Tersedia dan tersampainya informasi yang lebih mengutamakan keselamatan pasien dan keluarga
 - f. Tersedia dan tersampainya Promosi Kesehatan melalui media cetak seperti, leaflet, brosur, poster, dan media sosial seperti, Instagram, Facebook, dan Spotify
 - g. Meningkatnya partisipasi klien sehat dalam Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat atau komunitas berbasis Rumah Sakit baik melalui olahraga, kesenian, kerohanian, peningkatan keterampilan, bakat minat, dukungan serta Home Visite.
 - h. Terperingatinya hari-hari besar sebagai media dalam Promosi Kesehatan baik untuk meningkatkan pengetahuan pasien, pengunjung Rumah Sakit, dan mencari bakat dari SDM Rumah Sakit
 - i. Tersedia dan tersampainya informasi melalui media Kain Rentang
 - j. Tersedianya bantuan media alat peraga untuk memudahkan penyampaian edukasi dan informasi kepada pasien, keluarga serta pengunjung Rumah Sakit
 - k. Meningkatnya keterlibatan komunitas Masyarakat Rumah Sakit dalam upaya Pendidikan pasien dan keluarga berkelanjutan
 - l. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas pemberian edukasi dan informasi atau educator dengan adanya bimbingan teknis dan non teknis

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Visi PKRS

Membentuk Masyarakat yang tahu, mau, dan mampu melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative secara mandiri dan bertanggung jawab untuk mencapai derajat Kesehatan yang optimal.

2.2 Misi PKRS

- 1. Menyediakan waktu yang adekuat dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
- 2. Meningkatkan upaya kemitraan yang mendukung program Kesehatan
- 3. Memperkuat advokasi agar terbentuk kebijakan yang berwawasan Kesehatan
- 4. Mengupayakan pemberdayaan Masyarakat dan membentuk komunitas Kesehatan berbasis RSPHM

2.3 Motto : “4 IF 2 kreatif , aktIF , solutIF , responsIF”

2.4 7 Nilai Budi Utama

- a. Jujur + dipercaya
- b. Tanggung Jawab
- c. Visioner
- d. Disiplin
- e. Kerjasama
- f. Adil
- g. Peduli

2.5 SOTK



3.6 Permasalahan Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM / KASUS 2025	INDIKATOR		KETERANGAN
		BERHASI L	TIDAK BERHASI L	
1	Rapat TIM PKRS 2025	√		Pelaksanaan rapat masih terdapat beberapa unit yang belum aktif mengikuti jalannya pertemuan. Beberapa unit diketahui tidak hadir dan tidak berpartisipasi dalam pembahasan agenda rapat. Selain itu, terdapat beberapa PIC yang menyampaikan izin tidak dapat menghadiri rapat pada hari pelaksanaan (H-0) dengan alasan tertentu. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses koordinasi dan penyampaian tindak lanjut program di masing-masing unit.
2	Kebutuhan Leaflet	√		Banyak kotak leaflet yang masih kosong karena beberapa unit tidak melakukan pencetakan media. Hal ini disebabkan oleh kendala pada alat cetak yang belum dapat digunakan, sehingga distribusi leaflet ke masing-masing unit tidak berjalan optimal.
3	Pembuatan video a. Materi PPI b. Materi 10 besar Penyakit c. Video edukasi lainnya	√		Belum semua terealisasi, karena terkendala tim PKRS yang kurang.
4	Edukasi unit		√	Masih terdapat beberapa unit yang belum melaksanakan kegiatan edukasi sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya capaian indikator edukasi unit secara keseluruhan. Diharapkan tindak lanjut dapat dilakukan untuk memastikan setiap unit memenuhi target pada periode berikutnya.
5	Pelaporan Edukasi	√		Masih banyak unit yang menyampaikan laporan edukasi tidak tepat waktu dan melewati batas deadline yang telah ditentukan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan pengiriman laporan PKRS secara keseluruhan.
6	Pelatihan Internal	√		Kegiatan telah berjalan, namun masih terdapat beberapa staf di masing-masing unit yang belum mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut.

7	Pelatihan Eksternal		√	Belum terlaksana
---	---------------------	--	---	------------------

BAB III KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Melakukan Pengkajian	1) Melakukan Pengkajian kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien;
		2) Melakukan Pengkajian kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit
		3) Melakukan Pengkajian kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
2.	Membuat Perencanaan;	1) Sosialisasi Pedoman PKRS
		2) Sosialisasi Pedoman Komunikasi Efektif
		3) Telaah/Review/Sosialisasi/Revisi SPO
		4) Sosialisasi Pedoman Kerja Tim PKRS
		5) Membuat Program PKRS tahun 2026
		6) Membuat Program PKRS tahun 2026
		7) Merencanakan kebutuhan Staf Tim PKRS



		8) Merencanakan kebutuhan Peningkatan SDM untuk program PKRS (Diklat, WS)
		9) Merencanakan kebutuhan Logistik, media PKRS
3	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan program PKRS	1) Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan intervensi Promosi Kesehatan berfokus pada pasein dan keluarga Pasien
		2) Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaanintervensi Promosi Kesehatan pada SDM Rumah Sakit
		3) Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaanintervensi Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit
		4) Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Edukator bagi PPA
		5) Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Komunikasi efektif antar staf/PPA
		6) Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Komunikasi efektif seluruh staf RS
		7) Membuat laporan Program PKRS dan Tim PKRS (membahasnya melalui rapat Tim PKRS)



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

		8) Memberikan Feedback kepada unit pelaksana/lintas Program atas hasil kinerja PKRS
		9) Melaksanakan Bimtek kepada PIC PKRS

3.2 Sasaran Dan Tujuan

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDART	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Melakukan Pengkajian						
1)	Melakukan Pengkajiankebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien;	Mengetahui , mengidentifikasi kebutuhan promkes untuk pasien dan keluarga	Pasien dan Keluarga Pasien;	Pengkajian	1x/th	Terdapat bukti dokumen : 1.hasil pengkajian 2.laporan	
2)	Melakukan Pengkajian kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit	Mengetahui , mengidentifikasi kebutuhan promkes untuk SDM RS	Staf RS				
3)	Melakukan Pengkajian kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.	Mengetahui , mengidentifikasi kebutuhan promkes untuk masyarakat/komunitas	masyarakat/komunitas				
2.	Membuat Perencanaan;						
1)	Sosialisasi Pedoman PKRS	Menyebarkanluaskan regulasi terbaru	Regulasi	Regulasi	100%	UMANDOK	



2)	Sosialisasi Pedoman Komunikasi Efektif	Menyebarkan regulasi terbaru					
3)	Sosialisasi SPO	Menyebarkan regulasi terbaru					
4)	Sosialisasi Pedoman Kerja Tim PKRS	Menyebarkan regulasi terbaru					
5)	Membuat Program PKRS tahun 2026	Memberi acuan pada pelaksanaan program PKRS 2026				Proker PKRS 2026	
6)	Membuat Program kerja Tim PKRS tahun 2026	Memberi acuan pada pelaksanaan program Tim PKRS 2026				Proker Tim PKRS 2026	
7)	Merencanakan kebutuhan Staf Tim PKRS	Meningkatnya metode dan media untuk program PKRS	Design grafis Visual / D4	Rekrutmen	1	Penambahan 1 staf PKRS disetujui	
8)	Merencanakan kebutuhan Peningkatan kompetensi SDM untuk program PKRS	Meningkatnya komp-etensi SDM PKRS dan PPA	PPA All staf	Diklat	1x/th	TUMANDOK	
9)	Merencanakan kebutuhan Logistik, media PKRS	Mengetahui jumlah dan kebutuhan logistik termasuk media PKRS dalam 1 th	Unit	logistik	1x/th	Tercukupinya logistik PKRS semua unit di RS	
3	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan program PKRS						



1)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan intervensi Promosi Kesehatan berfokus pada pasein dan keluarga Pasien	Memastikan pelaksanaan intervensi promkes pada pasein dan keluarga Pasien	Pasien dan Keluarga Pasien;	Monev	1x/bl	Dokumen supervisi Laporan supervisi	
2)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan intervensi Promosi Kesehatan pada SDM Rumah Sakit	Memastikan pelaksanaan intervensi promkes pada Staf RS	Staf RS	Monev	1x/bl	Dokumen supervisi Laporan supervisi	
3)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan intervensi Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit	Memastikan pelaksanaan intervensi promkes pada Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit	masyarakat/komunitas	Monev	1x/bl	Dokumen supervisi Laporan supervisi	
4)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Edukator bagi PPA	Memastikan pelaksanaan Diklat Edukator bagi PPA	PPA	Monev	1x/th	Dokumen supervisi Laporan supervisi	
5)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Komunikasi efektif antar staf/PPA	Memastikan pelaksanaan diklat Komunikasi efektif antar staf/PPA sesuai TOR	PPA	Monev	1x/th	Dokumen supervisi Laporan supervisi	
6)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Komunikasi efektif seluruh staf RS	Memastikan pelaksanaan diklat Komunikasi efektif antar staf/PPA sesuai TOR	All staf	Monev	1x/th	Dokumen supervisi Laporan supervisi	



7)	Membuat laporan Program PKRS dan Tim PKRS	Membuat bukti pelaksanaan kepada Direktur RS	Tim PKRS	laporan	1x/bl	Bukti dokumen laporan bulanan lengkap/ tahunan	
8)	Memberikan Feedback kepada unit pelaksana/lintas Program atas hasil kinerja PKRS	Memberikan masukan dan membuat RTL	Lkintas program Unit manajemen	rapat	1x/bl	UMANDOK rapat	
9)	Melakukan bimbingan teknis kepada PIC PKRS	Monitoring & evaluasi kinerja PIC PKRS (RM terkait survei kelengkapan ERM komunikasi Efektif dan KIE)	PIC PKRS	Bimtek	4x/th	Laporan Bimtek dan rekapan supervise/survei kelengkapan komunikasi antar PPA dan edukasi pasien dan keluarga 100% dilakukan PPA	



3.3 Pelaksanaan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Melakukan Pengkajian						
1)	Melakukan Pengkajiankebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien;	Mengumpulkan data2 demografi pasien yang ada di Pengkajian kebutuhan edukasi total pasien dalam 1 tahun, 10 besar penyakit, melakukan analisa membuat kesimpulan untuk merencanakan intervensinya	Retro 1 tahun yang lalu	SIMRS	Awal tahun	Hasil pengkajian Tabulasi Data2 Analisis RTL	
2)	Melakukan Pengkajian kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit	Mengumpulkan data2 staf dari form pengkajian staf sebelum MCU, melakukan analisa membuat kesimpulan untuk merencanakan intervensinya	Retro 1 tahun yang lalu	SIMRS	Awal tahun		
3)	Melakukan Pengkajian kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.	Mengumpulkan data2 demografi pasien yg berkunjung di RS, komunitas, data dari Dinkes, melakukan analisa membuat kesimpulan untuk merencanakan intervensinya	Retro 1 tahun yang lalu	SIMRS	Awal tahun		



2	Membuat Perencanaan;						
1)	Sosialisasi Pedoman PKRS	1.membuat undangan, daftar hdr 2.menyiapkan materi 3. melaksanakan 4. membuat notulen 5. membuat laporan	rapat	daring	Januari 2026	UMANDOK	
2)	Sosialisasi Pedoman Komunikasi Efektif						
3)	Sosialisasi SPO						
4)	Sosialisasi Pedoman Kerja Tim PKRS						
5)	Membuat Program PKRS tahun 2026	Identifikasi masalah program belum tercapai th 2025, usulan2 dari unit, mengacu pada pedoman	Rapat	Luring	Januari 2026	UMANDOK	
6)	Membuat Program kerja Tim PKRS tahun 2026						
7)	Merencanakan kebutuhan Staf Tim PKRS	Membandingkan antara PMK 44 th 2028 dengan fakta existing				Bukti program PKRS 2026	
8)	Merencanakan kebutuhan Peningkatan kompetensi SDM untuk program PKRS	.mengumpulkan data IKP, mutu PKRS yang tidak tercapai komplain pasien, usulan unit, evaluasi hasil kegiatan th 2025, melakukan analisis, RTL,					
9)	Merencanakan kebutuhan Logistik, media PKRS		Form usulan unit	SIMRS		Rekapan Usulan kebutuhan logistik dan media PKRS	



3	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan program PKRS						
1)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan intervensi Promosi Kesehatan berfokus pada pasein dan keluarga Pasien	Menyiapkan ceklist & supervisi CMR, OMR dari kelengkapan Fom KIE , Form SBAR, Tranver pasien, Form rujuk, DP, Pemberian informasi sebelum tindakan, RPP	Ceklist	ERM	Tiap bulan	Hasil supervisi/survei Pelaksanaan KIE pasien & keluarga laporan	
2)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaanintervensi Promosi Kesehatan pada SDM Rumah Sakit	Menyiapkan ceklist & supervisi pemberian konseling dan KIE staf bermasalah kesehatan	Ceklist	Langsung /luring		Hasil supervisi/survei Pelaksanaan intervensi staf laporan	
3)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaanintervensi Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit	Menyiapkan ceklist & supervisi pelaksanaan KIE kelompok , massa dan pemberdayaan masyarakat berbais RS (Dolina, F-Kul, Sirrotul jannah, Komunitas profesi, UKS, LSM, LSOM)	Ceklist			Hasil supervisi/survei Pelaksanaan KIE kelompok, massa, pemberdayaan, laporan	



4)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Edukator bagi PPA	Menyiapkan ceklist & supervisi pelaksanaan Diklat Edukator bagi PPA	Ceklist	Langsung /luring	1x/th	Hasil supervisi/survei Pelaksanaan diklat RTL	
5)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Komunikasi efektif antar staf/PPA	Menyiapkan ceklist & supervisi pelaksanaan Diklat Komunikasi efektif antar PPA	Ceklist	Langsung /luring	1x/th		
6)	Melakukan Monitoring dan evaluasi.pelaksanaan Diklat Komunikasi efektif seluruh staf RS	Menyiapkan ceklist & supervisi pelaksanaan Diklat Edukator bagi PPA	Ceklist	Langsung /luring	1x/th		
7)	Membuat laporan Program PKRS dan Tim PKRS	1) Mengumpulkan data 2) Mentabulasikan 3) Membuat grafik jika perlu 4) Analisis data 5) Membuat RTL 6) Melaporkan kepada Direktur 7) Menyiapkan untuk materi pemberian feedback	Word softkopi	PC SIMRS	Tiap bulan < tanggal 3	Laporan lengkap sesuai tata naskah	
8)	Memberikan Feedback kepada unit pelaksana/lintas Program atas hasil kinerja PKRS	1.Menyiapkan materi 2.Memberi masukan 3.Melakukan diskusi 4.Membuat RTL	Rapat		Tiap bulan	Umandok	
9)	Melakukan bimbingan teknis kepada PIC PKRS						



3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1	Penambahan 1 staf PKRS Full Time (diutamakan yang latar belakang Pendidikan PROMKES)	Sarjanan DK/ D4 Promkes		√												RSPHM	SDM	PT. DPM	-
2	Pelatihan membuat leaflet	PIC PKRS		√												KOMPAS TV	SDM	PT. DPM	-
3	Pelatihan manajemen PKRS	PJ PKRS														BOGOR	SDM	PT. DPM	Sesuai jadwal eksternal
4	Orientasi umum – Pengenalan Program PKRS & Komunikasi Efektif Dasar	Staff Baru	TENTAIF MENYESUAIKAN JADWAL SDM												RSPHM (Hall Sakura)	SDM	-	-	
5	Refreshment Training : Komunikasi Efektif Medis & Non Medis	All Staf				√					√					RSPHM (Hall Sakura)	SDM	Dapur RSPHM	-
6	Pemberdayaan KOMUNITAS SENAM HAMIL	Komunitas Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHM (Hall Cordoba)	Pj kia	Dapur RSPHM	-
7	Pemberdayaan Komunitas KOMUNITAS GERIATRI	Komunitas Lansia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHM (lahan parkir samping kantin)	PJ Geriatri	PT. DPM	-
8	Pengembangan Media PKRS	Pasen, keluarga pasien, pengunjung SDM RS, dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHM	PJ Program PKRS	PT. DPM	-



NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
		Masyarakat sekitar RS																	
9	Pemberdayaan Komunitas Sirotul Jannah	Masyarakat sekitar RS yang beragama Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHM	PJ PKRS	PT. DPM	
10	Pembuatan video	5 program														RSPHM	PJ PKRS	PT. DPM	
11	KIE Individu	Pasien & Keluarga pasien,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHM	PIC PKRS Ruangan	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
12	KIE Kelompok	Pengunjung & Keluarga Pasien	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHM	PIC PKRS Ruangan	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
13	KIE Massa	Masyarakat sekitar & Followers media sosial RSPHM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Radio spot dan Medsos RSPHM	PJ Program PKRS	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
14	Peringatan Hari Besar	Pasien, Keluarga pasien, Pengunjung, SDM RS, dan Masyarakat sekitar RS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TENTATIF	PJ Program PKRS	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
15	CSR/ Edukasi Luar Gedung	Masyarakat sekitar RSPHM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Luar RS	PJ Program PKRS & Marketing	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
16	Supervisi (OMRR & CMRR)	Pasien, Keluarga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRNA, ICU, Maternitas, Perinatologi	PJ Program PKRS,	-	-



NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
		Pasien, Rekam Medis															Karu, PIC PKRS Ruangan		
17	PHBS Karyawan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCU	K3		
18	Rapat Tim PKRS	All PIC PKRS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHM (Hall Andalusia)	Ketua Tim PKRS	Dapur RSPHM	-

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring

Sesuai dengan Permenkes No. 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit, kegiatan monitoring PKRS dilakukan dalam bentuk :

- Melakukan Audit dengan metode Open Medical Record Review* yaitu metode telusur asuhan Pasien yang dilakukan pada saat Pasien masih dirawat. Pada metode ini memungkinkan untuk langsung diklarifikasi kepada Pasien dibandingkan dengan yang dicatat di rekam medik.
 - Melakukan Audit dg metode Close Medical Record Review* yaitu metode telusur asuhan pasien melalui rekam medik pada saat pasien sudah pulang perawatan.
 - Melakukan wawancara/ *cross cek* / verifikasi KIE pada saat pasien belum pulang.
 - Melakukan audit efektifitas hasil cakupan KIE Medsos
 - Focus Group Discussions* antara pelaksana-pelaksana/PPA yang dilaksanakan pada instansi/unit pelayanan di Rumah Sakit.
 - Melakukan supervisi dan pembinaan ke instalasi/unit-unit pelaksana PKRS oleh PJ-PKRS.
 - Menyelenggarakan pertemuan PIC- PKRS secara rutin (bulanan, tribulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk membahas permasalahan dan kendala terkait pelaksanaan PKRS di unit atau pengelola program.
-

4.2 Evaluasi

Sesuai dengan Permenkes No. 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit, kegiatan evaluasi PKRS dilakukan dalam bentuk :

- Pertemuan forum komunikasi yang melibatkan seluruh instalasi/unit terkait dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PKRS
- Menjalin kerja sama jaringan regional, nasional, dan internasional maupun kelompok Rumah Sakit yang telah melaksanakan PKRS
- Menginformasikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi PKRS melalui forum komunikasi atau berbagai jenis media
- Melakukan evaluasi dengan membandingkan keberhasilan RS lain dengan studi banding terhadap Rumah Sakit yang telah melaksanakan PKRS dengan lebih baik.
- Kajian Mutu oleh unit fungsional internal mutu rumah sakit atau menggunakan pihak lain untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pkrs.
- Rapat PIC PKRS tiap bulan
- Rapat antar program besar tiap 3 bulan sekali
- Rapat koordinasi tiap bulan



BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

1.1. Pencatatan

Semua kegiatan dilakukan pencatatan dimasukkan file disimpan untuk direkap sebagai laporan.

KIE pasien : Form Edukasi

Diklat : UMANDOK diarsipkan

KIE di media : direkapitulasi setiap bulan

Media Cetak : disebar di unit-unit dan file diarsipkan

Supervisi : dilakukan juga audit kelengkapan RM terkait Komunikasi efektif dan KIE

Data-data tersimpan di PC, Google

1.2. Laporan

Jenis pelaporan PKRS :

- a. bulanan,
- b. triwulan,
- c. tahunan



BAB VI PENUTUP

Demikian program kerja tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

Korektor
Ketua Tim PKRS

drg. Endy Wira Pradana, M.MRS

Malang, 07 Januari 2026
Penanggung Jawab Program PKRS

Mukhammad Eriko Firdaus, S.Kom

Menyetujui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes